

Дата: 26.05.2026

Полис ОМС: 5096379772000172

Медицинское учреждение : ГБУЗ ДГП 30 ДЗМ

Специализация: Заведующий структурным подразделением - врач ультразвуковой диагностики

ФИО: Страх А. П.

Эхокардиография

Информация об исследовании	Предварительный диагноз: Z00.1 - Рутинное обследование состояния здоровья ребенка Цель исследования: Диспансеризация / Профилактический осмотр Обоснование: приказ 211 Дата исследования: 26 мая 2026, 08:49.
Описание	Аппарат: VividS70N ЧСС 155 уд в мин. Устье аорты: 1,0 см. Синусы аорты: 1,0 см. Восходящая аорта: 1,0 см. Дуга аорты: 0,9 см. Перешеек 0,6 см. нисходящий отдел 0,8 см. Трансаортальный градиент давления: пиковый 5,0 мм. рт. Средний 2,5 мм. рт. ст. Аортальная регургитация : нет ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК: КДР 2,0 см., КРС 1,2 см., КДО-13 мл. КСО 4 см., УО 9 мл., ФВ-72%, ФУ-42%. ЗСЛЖ: 3,0 мм МЖП: 5,0 мм ПСПЖ: 2,5 мм Правый желудочек: 1,0 см. Левое предсердие: 1,0 см. Правой предсердие:1,0*1,4 см. МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН Характер движения створок: разнонаправленный. Фиброзное кольцо МК: 1,0 см Трансмитральный градиент давления: пиковый 3,0 мм. рт. ст. средний 1,5 мм. рт. ст. Митральная регургитация: нет ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ КЛАПАН: Фиброзное кольцо Т.К.: 1,0 см Транстрикуспидальный градиент давления: пиковый 1,7 мм. рт. ст., средний 0,7 мм. рт. ст. Транстрикуспидальная регургитация: 0-1 ст. Давление в ПЖ по трикуспидальной регургитации : 11 мм. рт. ст. Легочная артерия: ПУЛЬМОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН: Фиброзное кольцо П.К.: 0,9 см Транспульмональный градиент давления: пиковый 5 мм. рт. ст., средний 2,5 мм. рт. ст. Пульмональная регургитация: 0-1 ст . Наличие эхо – свободного пространства по ЗСЛЖ: в диастолу см. Наличие эхо – свободного пространства по ПСПЖ: в диастолу см. Нижняя полая вена 3,5 мм, коллабирование на вдохе более 50% КОММЕНТАРИИ: Полости сердца не увеличены, стенки не утолщены. Септальные дефекты не лоцируются. Экскурсия стенок удовлетворительная, движение МЖП обычное. Клапаны сердца без изменений. При ДКГ и ЦК получен незначительный сбросовый поток в правое предсердие на уровне овального окна. Аномально прикрепленные хорды в левом желудочке.
Заключение	По ЭхоКГ функционирует овальное окно(гемодинамически незначимо). Сократительная, систолическая функция удовлетворительная .